FACTEURS LIMITANT LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NÉS HOSPITALISES DANS L'UNITE DE NEONATOLOGIE DE LA PEDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE GAOUA

Présentatrice : TAMINI Laure

Auteurs : **Tamini Laure**, Ouoba Yempabou, Lankoande Bignanaboa, Nagalo Kisito, Kaboré Aïssata, Kaboré Sonia

Affiliations : Université Joseph KI-ZERBO, Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Santé du nouveau-né est une préoccupation mondiale
- Caractérisée par une mortalité néonatale élevée; PED++
- Décès nouveau-nés : **46%** décès des enfants de moins de 5 ans
- Selon OMS 75% de ces décès sont évitables
- Trois principaux problèmes de santé du NN : INN, asphyxie périnatale , prématurité
- CHR Gaoua: mortalité intra-hospitalière **21,4 ; 27,2%** (2016, 2017)
- But : contribuer à la réduction morbidité et mortalité néonatale

Objectif

Etudier les facteurs qui limitent la prise en charge des nouveau-nés hospitalisés dans l'unité de néonatologie du CHR de Gaoua

Matériel et méthode(s)

- Type d'étude : transversale à visée descriptive
- Cadre de l'étude : centre hospitalier régional de Gaoua
- Période : 02 au 15 Avril 2019
- Population d'étude : prestataires de soins unité de néonatologie

Matériel et méthode(s)

- Critères d'inclusion :
  - Etre prestataire de soins de l'unité de néonatologie du CHR
  - Présent durant la période de collecte
  - Consentant
- Echantillonnage : exhaustif ; n=18
- Méthode : Enquête

Matériel et méthode(s)

- Techniques : auto administration du questionnaire ; observation ; entretien
- Outils de collecte : questionnaire , guide d'entretien individuel , grille d'observation
- Considérations éthiques : anonymat et confidentialité
- Analyse des données : logiciels Word et Excel 2016

Résultats

Connaissances des prestataires de soins

- Pathologies fréquentes du nouveau-né : **39,8%**
- Signes de danger chez le nouveau-né : **40,6%**
- Éléments de surveillance : **45,6%**
- Conséquences : *diagnostics et mesures thérapeutiques inadéquats; augmentation de la mortalité néonatale*

Résultats

Attitudes et pratiques des prestataires de soins

- Mesures de prévention des infections respectées: **58,3%**
- Alimentation du nouveau-né bien conduite : **66,7%**
- Niveau de performance : **61,5%**
- Conséquence : contribuent à alourdir mortalité néonatal

Résultats

Soutien aux compétences des prestataires de soins:

- Formations continues faites : **37,5%**
- Supervision : **absence de supervision**
- Niveau de performance : **18,7%**
- Conséquence : *pas d'amélioration des pratiques*

Résultats

Disponibilité des ressources

- Médico-techniques : **90,2%**
- Médicaments et consommables : **91,1%**
- *En faveur de soins adéquats aux nouveau-nés*

Résultats

Organisation du service

- Staffs journalier **: 72,1%**
- Réunions mensuelles de service **: 60%**
- Absence de description de postes
- Absence répartition des tâches

Conclusion

- PEC des nouveau-nés en unité de néonatologie limitée par plusieurs facteurs, relevant surtout des prestataires de soins
- De l'organisation de l'unité de néonatologie.
- Renforcement des formations continues
- Tenue de staffs réguliers pourraient améliorer la PEC.

Merci pour votre attention